

INVESTIGACIÓN

Experiencias de jóvenes universitarios ante realización de prueba rápida de VIH

Experiences of young university students with rapid HIV testing

Experiências de jovens universitários com o teste rápido de HIV

Lucely Maas-Góngora ^{1*}

 <https://orcid.org/0000-0001-8081-9830>

Juan Yovani Telumbre-Terrero ²

 <https://orcid.org/0000-0002-8695-7924>

Lubia del Carmen Castillo-Arcos ³

 <https://orcid.org/0000-0002-4368-4735>

Gudelia Nájera-Gutiérrez ⁴

 <https://orcid.org/0000-0003-1586-6627>

María Claudia Morales-Rodríguez ⁵

 <https://orcid.org/0000-0001-8370-8458>

1. Doctora en Ciencias de Enfermería, Universidad Autónoma del Carmen, Ciudad del Carmen, Campeche, México.

2. Doctor en Salud Mental, Universidad Autónoma del Carmen, Ciudad del Carmen, Campeche, México.

3. Doctora en Ciencias de Enfermería, Universidad Autónoma del Carmen, Ciudad del Carmen, Campeche, México.

4. Doctora en Ciencias de Enfermería, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, Puebla, México.

5. Doctora en Ciencias de Enfermería, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, Puebla, México.

*Autor para correspondencia: lucelymaas@gmail.com

Recibido: 18/10/2024

Aceptado: 10/09/2025

Resumen

Introducción: El panorama del VIH sigue siendo uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial, resulta necesario abordar este fenómeno desde diferentes perspectivas para contribuir a sustentar propuestas de intervención y comprensión de este fenómeno de estudio.

Objetivo: Comprender las experiencias vividas ante la realización de la prueba rápida para

detección de VIH en jóvenes universitarios. **Metodología:** Estudio cualitativo, descriptivo, fenomenológico, realizada en 11 jóvenes universitarios, con al menos una experiencia en la realización de la prueba rápida para VIH; muestreo por conveniencia considerando la representatividad de la población, hasta la saturación de los discursos. Se desarrollaron entrevistas en profundidad, con las preguntas orientadoras, ¿Cuáles fueron los sentimientos que te acompañaron antes y durante la realización de la prueba rápida para la detección del VIH? y ¿Cómo fue tu experiencia para toma de la muestra? Se realizó un análisis interpretativo en cuatro fases. Todas las etapas se apegaron a los aspectos éticos de la investigación.

Resultados: Dos categorías expresaron los significados otorgados a la experiencia de la toma de la muestra: Normalizar la toma de la prueba para superar barreras, se refiere a cómo los conocimientos y creencias, surgen como obstáculo para la aceptación de la prueba; y La Experiencia positiva... ¿y la siguiente? se refiere a la experiencia positiva en la toma de la muestra, no obstante, ciertas creencias condicionan el diagnóstico precoz. **Conclusiones:** A partir de las experiencias de jóvenes, se subraya la importancia de la desmitificación de la enfermedad del VIH y las pruebas rutinarias accesibles.

Palabras clave: Pruebas de diagnóstico rápido; VIH; Experiencias de vida; Fenomenología (DeCS).

Abstract

Introduction: HIV remains one of the biggest public health problems worldwide. To contribute to sustained intervention proposals and understanding of this phenomenon, it is necessary to address it from different perspectives. **Objective:** To gain an understanding of the experiences of young university students undergoing rapid HIV testing. **Methodology:** This qualitative, descriptive and phenomenological study was performed with 11 young university students who had experienced rapid HIV testing at least once. Convenience sampling was employed to ensure representativeness of the population until discourse saturation was reached. In-depth interviews were conducted using the following guiding questions: “What feelings did you experience before and during the rapid HIV test?”, and “How was your experience of having the sample taken?” An interpretative analysis was carried out in four phases. All stages of this study adhered to the ethical aspects of research.

Results: Two categories emerged that expressed the meanings attributed to the experience of sample collection: “Normalizing testing to overcome barriers”, which refers to the obstacles to accepting testing that arise from knowledge and beliefs, and “Positive experience... what about the next one?” which refers to the positive experience of sample collection. However, certain beliefs can hinder early diagnosis. **Conclusions:** Based on young people's experiences, it is clear that HIV must be demystified, and the importance of routine testing must be promoted.

Key words: Rapid diagnostic tests; HIV; Life experiences; Phenomenology (DeCS).



Abstrato

Introdução: O panorama do HIV continua sendo um dos maiores problemas de saúde pública em nível mundial, sendo necessário abordar esse fenômeno a partir de diferentes perspectivas, com o objetivo de contribuir para sustentar as propostas de intervenção e compreensão desse fenômeno em estudo. **Objetivo:** Compreender as experiências vividas diante da realização do teste rápido para detecção do HIV em jovens universitários. **Metodologia:** Estudo qualitativo, descritivo e fenomenológico, realizado com 11 jovens universitários, com pelo menos uma experiência na realização do teste rápido para HIV; amostragem por conveniência, considerando a representatividade da população, até a saturação dos discursos. Foram realizadas entrevistas em profundidade, com as seguintes perguntas orientadoras: Quais foram os sentimentos que você teve antes e durante a realização do teste rápido para detecção do HIV? e Como foi sua experiência com a coleta da amostra? Foi realizada uma análise interpretativa em quatro fases. Todas as etapas seguiram os aspectos éticos da pesquisa. **Resultados:** duas categorias expressam os significados que este grupo atribui à experiência da coleta da amostra: Normalizar a realização do teste para superar barreiras, refere-se a como os conhecimentos e crenças surgem como obstáculo para a aceitação do teste; e Experiência positiva... e a próxima? Que expõe que, apesar da experiência, existem crenças que condicionam o diagnóstico precoce. **Conclusões:** destaca-se a importância de normalizar a coleta da amostra como parte de uma atividade regular e cotidiana para os jovens.

Palavras-chave: Teste de diagnóstico rápido; HIV; Experiências de vida; Fenomenologia (DeCS).

Introducción

La investigación cualitativa parte de la idea de que, como seres sociales, todas las personas son a la vez creadoras y consumidoras de un mapa mental intersubjetivo que influye en cómo se percibe el mundo ⁽¹⁾. En este sentido, para este estudio acercarse desde un análisis subjetivo a las vivencias de jóvenes ante la realización de la prueba de VIH, resulta relevante ya que en los grupos sociales hay aspectos simbólicos que determinan una conducta como puede ser, el modo en que concibe la salud y/o la enfermedad.

En la realización de pruebas rápidas de detección de VIH no solo implica un procedimiento técnico, sino que evoca experiencias emocionales complejas, estas experiencias pueden influir en la decisión de someterse a la prueba, en la adherencia de protocolos de prevención y en la percepción de la salud sexual. Considerando lo anterior, la fenomenología, por su parte, es un método de investigación cualitativa, que permite el estudio de aspectos subjetivos desde la esencia de los



fenómenos, tal como se presentan en su contexto natural, a estos se lo conoce como, experiencia vivida; este método se interesa en analizar y comprender los significados incorporados en el sujeto, desde su vivencia y antes de ser teorizados ⁽²⁾.

Actualmente el panorama del VIH sigue siendo uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial, hasta finales de 2022 se estimaba que había 39 millones de personas viviendo con esta condición ⁽³⁾. Según la ONUSIDA durante ese mismo año, 1.3 millones de personas contrajeron la infección por el VIH y 630,000 personas murieron debido a enfermedades relacionadas con el VIH ⁽⁴⁾. En México hasta el año 2023, la prevalencia de VIH en el total de la población fue de 0.3% lo que significa que tres de cada mil personas viven con el VIH, aunque se considera una prevalencia baja, esta tendencia no se ha modificado en los últimos 10 años; para el 2022 se presentaron 20 mil nuevas infecciones ⁽⁵⁾. Se destaca la importancia del diagnóstico oportuno, en este sentido las pruebas rápidas han mostrado gran efectividad para la prevención y control del VIH/SIDA, facilitando, el acceso al tratamiento y con ello evitar nuevas infecciones ⁽⁴⁾. En la búsqueda de estudios previos se identificó resultados como los de Piedrahita, et al., ⁽⁶⁾ que indicaron que los conceptos socioculturales que se han erigido en torno al VIH se han convertido en una barrera de acceso a los servicios de salud, debido al estigma social, el significado religioso y los mal denominados grupos de riesgo asociados al virus. En un estudio latinoamericano, mostró que para los jóvenes con situación económicamente más alta tiene mayores probabilidades de tener conocimientos correctos respecto a la transmisión del VIH, así como uso del preservativo, al respecto de las pruebas mostró desigualdades según el país ⁽⁷⁾. Mientras que Martin, et al., ⁽⁸⁾ reconocieron que la conciencia de las personas de someterse a las pruebas se vio influida de forma significativa por su conocimiento del riesgo de infección, la importancia que le da a las pruebas para detección de enfermedades de transmisión sexual y confianza en la realización muestra.



Aunque existen estudios sobre la aceptación de pruebas de VIH en población de jóvenes, pocos adoptan una perspectiva cualitativa fenomenológica que explore la esencia de la experiencia vivida en particular en contextos latinoamericanos o similares, donde factores socioculturales como el machismo, la religión, pueden modular dichas vivencias.

La enfermería, como disciplina centrada en el cuidado holístico, juega un rol primordial en la administración de pruebas rápidas de VIH, es responsable del asesoramiento pre y post prueba, así como de la educación para la prevención. Reflexionar sobre las experiencias de los jóvenes, permitirá diseñar estrategias más empáticas y efectivas. Este conocimiento no solo enriquecerá la práctica clínica sino contribuirá a integrar dimensiones subjetivas en modelos de cuidado. En este contexto se planteó como objetivo comprender las experiencias vividas ante la realización de la prueba rápida para detección de VIH en jóvenes universitarios.

Metodología

Se desarrolló un estudio cualitativo, descriptivo, exploratorio, que indagó el significado de las experiencias de vida, tomando como base que los estudios cualitativos permiten investigar fenómenos en sus entornos naturales, con el objetivo de explicar o interpretar los acontecimientos en términos de los significados que las personas les atribuyen, es una metodología subjetiva que pretende dar cuenta de las interacciones observadas por el investigador ⁽⁹⁾. Tiene un enfoque fenomenológico, ya que explica la naturaleza del fenómeno de estudio y dado que se trata de observar el mundo real desde reflexiones, historias, relatos que los participantes consideren importantes y significativos ⁽¹⁰⁾.

La muestra fue por conveniencia, empleando un muestreo por invitación directa hasta la saturación de los discursos. Los sujetos informantes fueron 11 estudiantes de licenciatura de una universidad pública, que tenían al menos una experiencia en la realización de la prueba diagnóstica rápida para VIH, proporcionada o no por la universidad. Para la elección se tomó en cuenta las vivencias con



relación al fenómeno abordado, así como la disponibilidad, la facilidad para hablar sobre sus experiencias y la capacidad auto reflexiva para expresar sus sentimientos fue acumulativo hasta lograr la información suficiente para responder al objetivo de investigación ⁽¹¹⁾.

Se desarrollaron entrevistas en profundidad las cuales se realizaron en un espacio cerrado, en uno o dos encuentros cara a cara entre el investigador y el participante, las entrevistas tuvieron como objetivo la comprensión de las perspectivas que los informantes tenían con respecto de sus vidas o sucesos a través de una conversación entre iguales y no de intercambio de preguntas y respuestas ⁽¹¹⁾. Dado que se trata de un proceso conversacional flexible, no estructurado, se plantearon dos preguntas orientadoras, pero como la intención fue profundizar, existieron otras que permitieron el flujo natural de la conversación ¿Cuáles fueron los sentimientos que te acompañaron antes y durante la realización de la prueba rápida para la detección del VIH? y ¿Cómo fue tu experiencia para toma de la muestra? Estas entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas en un procesador de textos, se realizó la codificación por entrevista y línea por línea.

El estudio fue dictaminado por el Comité de Ética de la institución responsable con registro FCS019/2024. El participante recibió información sobre los objetivos del estudio, uso de la información, riesgos y características del estudio, se leyó el consentimiento informado, se respondieron las dudas con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el reglamento de la ley general de salud en materia de investigación ⁽¹²⁾.

Para el análisis de la información se utilizaron cuatro pasos sugeridos por Duque ⁽¹³⁾, el primero y con la finalidad de familiarizarse con las entrevistas, los investigadores encargados de la codificación las leyeron de forma independiente y reflexiva, tomando notas al margen, de la información digna de mención o que se consideró relevante para el objeto de estudio y respondiera al propósito del estudio. El segundo paso y una vez finalizadas las lecturas iniciales, los investigadores trabajaron juntos para buscar temas que fueran coincidentes con el fin de iniciar el



proceso de reducción de la información. Estos primeros pasos, permitieron la triangulación de expertos, revelando coincidencias y contradicciones, con la intención de fortalecer la calidad de la investigación ⁽¹³⁾. En el paso tres, los temas emergentes se categorizaron en función de sus conexiones lógicas o características compartidas. Finalmente, en el paso cuatro se definieron las siguientes categorías, (Tabla 1).

Tabla 1. Categorías y temas, 2025

Categorías	Temas emergentes
Normalizar la toma de la prueba para superar barreras	Conocimientos erróneos, insuficientes.
	Creencias.
	Falta de percepción de riesgo.
	Conocimientos erróneos, insuficientes.
	Creencias.
	Falta de percepción de riesgo.
	Sentimientos de miedo y temor.
Experiencia positiva... ¿y la siguiente?	Preocupación, dudas.
	Estigma.
	Experiencias positivas.

Fuente: Elaboración propia

Resultados

El 55 % fueron mujeres y 45 % varones; de entre 17 y 22 años, pertenecientes a una universidad pública del sureste de México. Posterior al análisis, las categorías identificadas fueron, Normalizar la toma de la prueba para superar barreras y Experiencia positiva... ¿y la siguiente?.

La categoría normalizar la toma de la prueba para superar barreras, surge a partir de los códigos identificados en el grupo de estudio. Se centró en cómo los conocimientos limitados, la falta de percepción de riesgo, expectativa de los resultados y las creencias relacionadas al estigma sobre la enfermedad, actuaron como obstáculos para la aceptación y realización de la prueba.

Discursos como *“Realmente no sabía que existía una prueba rápida”* (E1), *“No sabía dónde las realizaban”* (E7), *“Me habían comentado que se hacía un día antes y se le extraía la prueba de sangre y posteriormente se les daba el resultado, nunca me había hecho una rápida ni tampoco*

me la había practicado” (E8), “Yo pensé que te sacaban sangre y que iba a tardar horas” (E10), “Creí que me iban a sacar sangre del brazo no del dedo y no sabía que iba a ser tan rápida creí que iba a tardar como una hora o algo así “(E11), dieron cuenta de la falta de información sobre las características, tiempo y formas de la toma de la muestra.

Otro aspecto importante, estuvo relacionado con los códigos, donde los entrevistados mostraron una mirada optimista, asumieron que su estado de salud actual eliminaba la necesidad de pruebas de detección o reducía la motivación de acciones de detección, se expresaron: *“realmente no se mucho de la prueba, precisamente porque yo me considero siempre sana, no lo creo necesario” (E9) y “la confianza que uno tiene y dice, no es que a mí no me va a pasar nada” (E10).*

Al respecto de los sentimientos previos o durante la realización de la prueba, expresaron sentir, miedo, temor, incertidumbre, principalmente. La expectativa de un resultado positivo a VIH es el mayor promotor de miedo y temor: *“miedo de pensar que pasará si los resultados no son los esperados” (E1), el miedo de que puedan salir positivos y evitarlo y mejor el desconocimiento de si lo tengo o no... no quiero saber yo siento eso el miedo y de no saber qué hacer si los resultados no son los esperados” (E2), “antes de la prueba, fue una experiencia de temor, de miedo, de dudas” (E3), “de miedo la verdad pues tengo un antecedente de tener un familiar directo con VIH” (E5), “da miedo a que le estén realizando la prueba y te digan sabes que, eres positivo” (E7), “me sentí un poquito nerviosa y si salgo positiva que voy a hacer “(E11).*

Otros elementos emergentes en las entrevistas sobre la preocupación fue sobre su propia salud, que impulso la toma de pruebas diagnósticas, surgieron la preocupación como un sentimiento, las dudas sobre el estado de salud, especialmente en relación con las enfermedades de transmisión sexual, esta inquietud impulsó a los jóvenes a buscar en principio información, así como una certeza de estar sano, aunque la población entrevistada expuso la idea de estar haciendo las cosas bien, buscaron la forma de confirmar esto, algunos discursos asociados fueron: *“A veces fallan (los*



preservativos), yo sé que he sido responsable, pero pudo haber fallado algo “(E1), *“con una vida sexual activa y por mucho que te cuides tienes como ese cierto miedo de sí me estoy cuidando bien* “(E6), *“sé que me protejo en absolutamente todos los aspectos, pero pues nunca está de más realizarme una prueba de VIH”* (E7), *“a pesar de que considero que tomo mis medidas y precauciones a veces pueden pasar resultados inesperados”* (E8), *“mis amigos se sienten confiados de que no tienen nada, dicen... yo no tengo nada yo no me ando metiendo con cualquiera creen que por que están sanos ahorita, siempre lo van a estar”* (E9), *“puede que no sea 100 % seguro, aunque yo realmente haya sido muy cautelosa”* (E10), *“uno nunca sabe dónde se mete... se le alborotan las hormonas y pues anda metiéndose en lugares donde no debe, la calentura puede más que todo”* (E2).

Finalmente, se dejó ver el estigma asociado a la enfermedad y el miedo a la discriminación que pueden disuadir a las personas a buscar un diagnóstico precoz, especialmente en jóvenes que aún están en la formación del descubrir de su sexualidad, tanto en el plano gozoso como reproductivo. *“Las personas piensan que si alguien es portador de VIH, lo va a infectar por el simple hecho de convivir con ella... todavía existe mucha discriminación al respecto entonces creo que todo esto genera como esta pequeña tensión en los jóvenes, como, de yo no me la voy a hacer y prefiero no saber si tengo o no tengo, por el miedo al qué dirán, por el simple hecho de que alguien dice, me voy a ir a hacer la prueba de VIH es como de que, por?, o sea lo vemos como algo malo, cuando es algo normal”* (E4), *“qué tal si ves a un conocido, donde se realicen las pruebas, da el miedo de decirle, vine a ver si soy positivo en VIH y eso pues genera un rechazo en la sociedad, te ven como alguien infectado que no te tienes que acercar a él”* (E5), *“las personas no vienen por miedo que los juzguen, al qué dirán de mí, es decir que pasa si realmente tengo VIH”* (E8),” *pensaba, y si salgo positivo y luego todos se van a enterar y da miedo, aunque sabemos que tocando a la persona*



no contagia ni nada, hay personas que si saben que tienen eso, no se acercan, tienen miedo a ser rechazados” (E11).

En la categoría, experiencia positiva... ¿y la siguiente?, esta categoría surgió a partir de cómo los entrevistados reconocieron que las pruebas rápidas para detección de VIH son una herramienta importante en la lucha contra la propagación del virus ya que pueden proporcionar resultados rápidos y accesibles, lo que facilita la detección temprana y la intervención adecuada, además expresaron experiencias positivas posterior a la prueba. Para este grupo la experiencia iba de la incertidumbre inicial y la reconciliación con la decisión tomada, se logró percibir a la prueba como algo necesario, pero destacó una falta de conciencia previa “no lo sabes”. Algunos códigos destacan, la cercanía del lugar, facilidad, rapidez y su aspecto gratuito, también reconocieron la importancia que se realice en un entorno familiar, así como el trato del personal que les dio confianza, y dado que todos los entrevistados obtuvieron resultados negativos les significó un alivio y tranquilidad.

Sin embargo, la experiencia positiva de una vivencia, no cambian las creencias, estereotipos y valores que han permitido al joven posicionarse en su entorno social. Es por lo que se expresa a manera de pregunta ¿y la siguiente?, ya que, en la siguiente prueba, el miedo, el temor y la incertidumbre seguirán presentes, en la siguiente ocasión no por desconocimiento de la prueba, sino por la expectativa del resultado.

Los códigos asociados fueron: *“No me arrepiento es que al principio estaba un poco dudosa de venir, pero como fue súper rápido, no me quito mucho tiempo y no me arrepiento haberla hecho”* (E1), *“qué bueno que vinieron porque o sea son cosas que son necesarias pero que no lo sabes”* (E2), *“fue bastante rápido, soy un poco traumatado con las inyecciones, pues no tuve tanto dolor”* (E5), *“son gratis y pues debemos de aprovechar si están aquí en campaña, se busca no sentirse juzgado si llegas a pedir esta prueba, me sentí súper bien muy tranquila, nada más el nerviosismo*



por el pinchazo” (E7), “nunca me había hecho una rápida ... fue la experiencia aquí bastante grata, es bueno que la universidad se preocupe por eso, me siento muy feliz con los resultados y como se manejaron las pruebas y el protocolo” (E8), “no tenía conocimiento de nada de esto, la primera vez creí que tenía que llevar algún documento en especial o ir en ayunas o algo así, pero no, me explicaron muy bien y gané tranquilidad mental” (E9), “ya después cuando vi (el resultado), dije gracias, que alivio” (E10).

Discusión

Los resultados obtenidos destacaron, el desconocimiento sobre la existencia y aspectos técnicos de la prueba de detección rápida de VIH, la vivencia previa a la toma de la muestra generó sentimientos que en algunos casos hizo dudar su realización. Otro aspecto a considerar fue el estigma que prevaleció sobre la enfermedad y que de igual manera condiciona la decisión de realizar la prueba. Es importante reflexionar lo que emerge posterior a la experiencia, ya que se descubren sus desventajas y se valoran aspectos beneficiosos de la prueba rápida, lo que se considera de ayuda para las siguientes pruebas, pero no necesariamente le quita las barreras para los próximos diagnósticos.

En este sentido, se discutieron los resultados destacando algunos estudios previos relacionados con las categorías emergentes, que han reportado que los jóvenes tenían conocimientos aceptables sobre las formas de transmisión y riesgos del VIH y en general de las enfermedades de transmisión sexual, sin embargo, tenían creencias erróneas sobre el diagnóstico, tratamiento eficaz y/o características de la prueba ⁽¹⁴⁻¹⁶⁾, resultados que coincidieron con los hallazgos de este estudio, donde los participantes también mostraron falta de información sobre la prueba, otro estudio reportó un nivel bajo de conocimientos en más de la mitad de la muestra ⁽¹⁷⁾.



Para este estudio, es interesante resaltar que más allá de tener o no un conocimiento sobre la prueba, mostraron percepciones erróneas, desactualizadas o que provenían de fuentes no formales, con expresiones como “me han comentado”. Existieron coincidencias sobre la falta de experiencia en las pruebas, ya sea por los sentimientos que le generaban (miedo) o porque nunca habían sentido la necesidad, “*yo no tengo nada, no me ando metiendo con cualquiera*”, que además mostraron la continuidad del estigma asociado a la enfermedad. Todos los participantes del estudio acudieron de manera voluntaria por invitación, otros autores reportaron buena aceptabilidad de la prueba rápida, principalmente si era auto-administrada ⁽¹⁸⁻²⁰⁾.

Se recalca que no se trata de saberes adquiridos o no, sino de representaciones de un grupo, como, las creencias sobre la enfermedad, que pese a las campañas para evitar el estigma no adquirieron un estatuto de normalizado en la población informante. En este sentido, un estudio cualitativo reveló que las percepciones de los participantes entorno al VIH están moldeadas por el entorno social el cual define lo que es considerado habitual o tolerable ⁽²¹⁾. Así mismo, los resultados obtenidos con una población latinoamericana con un grupo de edad similar, mostraron coincidencias importantes, al reportar cerca de un tercio de la población estudiada se había realizado la prueba; el principal motivo fue la sospecha de contagio y los motivos más frecuentes para la no realización fue falta de tiempo y baja percepción de riesgo ⁽²²⁾.

En el presente estudio existieron expresiones como “*mis amigos se sienten confiados de que no tienen nada*” o “*sé que me protejo en absolutamente todos los aspectos*”, que se relacionan con la falsa pretensión de que a ellos no les pasará y la baja percepción de riesgo de contagio, independientemente del género. En este sentido, datos encontrados acerca de la percepción de riesgo de contagio de VIH, identificaron una categoría de invulnerabilidad que expone la idea que los jóvenes no corren peligro ⁽²³⁾ sin embargo, un investigador encontró diferencias de esta percepción, donde resultó mayor en hombres que en mujeres, así como la opción “*hacerse la prueba era una*



medida para protegerse del VIH” fue mencionada en segundo lugar y reconocida como método de prevención, aunque en el estudio mencionado más de la mitad de los encuestados nunca se habían realizado una prueba ⁽²⁴⁾.

Al respecto de los datos emergentes de aspectos relacionados con las creencias sobre la enfermedad, los jóvenes expresaron que no habían tenido la experiencia en la prueba, sin embargo, esperaban el señalamiento de sus compañeros, se deja ver la marca asociada a la enfermedad y como se otorga valor negativo, como antesala para una futura discriminación. Se ha evidenciado que el estigma influyó en la decisión para realizar la prueba, ya que actúa como barrera para la prevención, el tratamiento, la atención y el diagnóstico oportuno ⁽²⁵⁻²⁸⁾, los discursos que expusieron los entrevistados fueron en relación con *“evitar la prueba por temor a ser juzgados o señalados por sus compañeros”*.

Los participantes reflejaron una experiencia positiva y transformadora para los participantes en las pruebas rápidas, los puntos coincidentes fueron la rapidez, gratuidad, cercanía, claridad de la información y un ambiente no juzgador, que fomentó una experiencia grata, se transmitió alivio y satisfacción. Se encuentra coincidencias con estudios que mostraron En otros estudios la experiencia de los usuarios ante la prueba rápida, exponen que la confidencialidad, los horarios de atención flexibles y el asesoramiento previo y posterior, así como el lugar accesible y la privacidad son facilitadores para realizar la prueba ^(29,30).

Resulta llamativo como los jóvenes entrevistados que se sometieron a la prueba rápida pueden cambiar de parecer post prueba, eso no necesariamente implica una reconfiguración de la relación con la representación, pues no hay un conocimiento que se presente como nuevo, pero lo que sí es que la angustia hacia el resultado se disuelve, al menos en lo inmediato, todo queda restablecido, se puede mirar con el resultado negativo con cierto aprecio de beneficio y tranquilidad por los diferentes valores agregados que le asignan como el tiempo de respuesta, los bajo costos y sobre



todo la accesibilidad. Lo que si obtienen es una experiencia nueva, ya que ahora saben los aspectos técnicos de la prueba. Salvaguardada la angustia y el estigma asumen una posición más objetiva frente a la prueba, incluso se pueden ubicar códigos como *“felicidad, son necesarias, muy tranquila, nerviosismo solo por el pinchazo”* entre otros, lo cual cambia de forma radical la representación de la prueba antes de hacerla.

Entre las limitaciones del estudio, se encontró que la selección de los participantes estuvo limitada a un grupo de jóvenes que voluntariamente acudió a la toma de muestra lo que restringió la cantidad y tiempo para la etapa de recolección de información. A manera de sugerencia, se pudo ampliar la información recabada en la fecha de datos sociodemográficos a fin de tener datos cuantitativos para tener un mejor panorama de la población de estudio.

Conclusiones

El presente estudio cualitativo con enfoque fenomenológico ha permitido explorar las experiencias vividas por jóvenes universitarios ante la realización de la prueba rápida de VIH, revelando significados que este grupo asigna a la experiencia. Las categorías emergentes, Normalizar la toma de la prueba para superar barreras y Experiencia positiva... ¿y la siguiente?, responden a esas vivencias. La primera resalta la existencia de obstáculos para la realización de la prueba, como el miedo, el estigma y la falta de conocimientos, así como la información errónea. La segunda subraya los aspectos positivos posterior a la experiencia, como la rapidez, del procedimiento, la confidencialidad, el apoyo de los profesionales.

Este estudio destaca la importancia de contextualizar las experiencias juveniles en un marco donde la salud sexual sigue siendo un tema significativo de atención, evidenciando que las intervenciones preventivas y educativas deben priorizar la desmitificación del VIH, así como la promoción de pruebas rutinarias en espacios cercanos a los jóvenes. Los resultados pretenden aportar evidencia



cualitativa para diseñar estrategias personalizadas que aborden las necesidades de este grupo en riesgo.

Es de singular importancia normalizar la toma de la muestra como parte de una actividad regular y cotidiana para ellos. Otro aspecto a considerar son las actividades que aumenten la demanda de las pruebas, como proporcionar información en específico sobre la misma y sus beneficios, así como hacer conciencia sobre la responsabilidad para el cuidado de su propia salud.

Este estudio recalca la importancia del rol de las enfermeras como agentes clave, quienes generalmente son las encargadas de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades como el VIH.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe ningún conflicto de intereses.

Financiamiento

Los autores declaran que no existió ningún tipo de financiamiento.

Inteligencia artificial

Los autores declaran que no han utilizado ningún tipo de recurso de la inteligencia artificial en alguna de las secciones de este manuscrito.

Referencias bibliográficas

1. Marrero-Pérez MD, Gutiérrez-López D, Ruiz-Pérez PJ. El paradigma de investigación cualitativa en la educación médica. Edumecentro [Internet]. 2022 [citado 25 abr 2025];14(1):1-18. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742022000100037&lng=es
2. Sanguino NC. Fenomenología como método de investigación cualitativa: preguntas desde la práctica investigativa. Revista latinoamericana de metodología de la investigación social. [Internet] 2020 [citado 25 abr 2025];1(20):7-18. Disponible en: reelmis.com.ar/ojs/index.php/reelmis/article/view/fenomenologia_como_metodo
3. Organización Mundial de la Salud (OMS). 10 datos sobre el VIH/sida. OMS [Internet]. 2024 [citado 25 abr 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/facts-in-pictures/detail/hiv-aids>
4. Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA). Actualización mundial sobre el Sida 2022 [Internet]. 2022 [citado 25 abr 2025]. Disponible en: <https://www.unaids.org/es/resources/documents/2022/in-danger-global-aids-update-summary>



5. Centro Nacional para la prevención y el control del VIH y el Sida (CENSIDA). Boletín especial: Día mundial del sida. CENSIDA [Internet]. México; 2023 [citado 25 abr 2025]. Disponible en: <https://www.gob.mx/censida/documentos/boletin-de-atencion-integral-de-personas-con-vih>
6. Piedrahita LB, Moya LP, Posada IC, Román VB. Concepto sociocultural del VIH y su impacto en la recepción de campañas de promoción de la salud en Medellín. Ciencias de la Salud [Internet]. 2017 [citado 25 abr 2025];15(1):59-70. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5881440>
7. Gutiérrez JP, Trossero A. Socioeconomic inequalities in HIV knowledge, HIV testing, and condom use among adolescent and young women in Latin America and the Caribbean. Revista Panamericana de Salud Pública [Internet]. 2021 [citado 25 abr 2025];45:e47. Disponible en: <https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.47>
8. Martin K, Wenlock R, Roper T, Vera J. Facilitators and barriers to point-of-care testing for sexually transmitted infections in low- and middle-income countries: a scoping review. BMC infectious diseases [Internet]. 2022 [citado 25 abr 2025];20:22(1):155-162. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12879-022-07534-9>
9. Tejero-González J. Técnicas de investigación cualitativa en los ámbitos sanitario y sociosanitario. Ed. Universidad Castilla La Mancha [Internet]. 2021 [citado 25 abr 2025]. Disponible en: <https://www.torrossa.com/it/resources/an/4943831>
10. Mendieta-Izquierdo G, Ramírez-Rodríguez J. La fenomenología desde la perspectiva hermenéutica de Heidegger: una propuesta metodológica para la salud pública. Revista Facultad Nacional de Salud Pública [Internet]. 2015 [citado 25 abr 2025];33(3):435-443. Disponible en: <https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.v33n3a14>
11. Ríos-González C. Investigación cualitativa en el contexto de la salud pública: actualización de conceptos. Revista de salud pública del Paraguay [Internet]. 2024 [citado 25 abr 2025];7;14(1):51-58. Disponible en: <https://revistas.ins.gov.py/index.php/rspp/article/view/330>
12. Secretaría de Gobernación. Norma Oficial Mexicana NOM 010. Diario Oficial de la Federación [Internet]. Gobierno de México; 2023 [citado 25 abr 2025]. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5690938&fecha=02/06/2023#gsc.tab=0
13. Duque H, Granados ET. Análisis fenomenológico interpretativo: Una guía metodológica para su uso en la investigación cualitativa en psicología. Pensando Psicología [Internet]. 2019 [citado 25 abr 2025];7;15(25):1-24. Disponible en: <https://doi.org/10.16925/2382-3984.2019.01.03>
14. Ceballos RM, Hernández-García F, Delgado ML, Romero LA, Abad SA, Lazo HL. Conocimientos y percepción de riesgo de estudiantes de estomatología frente al VIH/sida. Revista Cubana de Educación Médica Superior [Internet]. 2022 [citado 25 abr 2025];36(1):1-16. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=113936>
15. Voyiatzaki C, Venetikou MS, Papageorgio E, Anthouli-Anagnostopoulou F, Simitzis P, Chaniotis DI, et al. Knowledge and risky behaviors of sexually transmitted diseases among young people in Greece. Int. J. Environ. Res. Public Health [Internet]. 2021 [citado 25 abr 2025];18:10022. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/ijerph181910022>
16. Flores-Garcés L, Conei-Valencia D, Flores-Urbe L. Conocimientos acerca del virus de inmunodeficiencia humana de estudiantes de las comunas de Coyhaique, Aysén y Cisnes. Revista Matronería Actual [Internet]. 2022 [citado 25 abr 2025];26(1):35-44. Disponible en: <https://doi.org/10.22370/revmat.1.2022.3159>
17. Lima MS, Raniere JC, Paes CJ, Gonçalves LH, Cunha CL, Ferreira GR, et al. Associação entre conhecimento sobre HIV e fatores de risco em jovens amazônidas. Revista Brasileira de



- enfermagem [Internet]. 2020 [citado 25 abr 2025];8;73:e20190453. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0453>
18. Zhang S, López I, Washington B, Gaudet B, Rodriguez CA, Sanders LJ. Assessing the attitude of Tampa Bay youth toward HIV self-testing kits. *Tropical Medicine and Infectious Disease* [Internet]. 2021 [citado 25 abr 2025];25;6(3):111-119. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/tropicalmed6030111>
 19. Anikamadu O, Ezechi O, Engelhart A, Nwaozuru U, Obiezu-Umeh C, Ogunjemite P, et al. Expanding youth-friendly HIV self-testing services during the COVID-19 pandemic: Qualitative analysis of a crowdsourcing open call in Nigeria. *JMIR formative research* [Internet]. 2024 [citado 25 abr 2025]; 30;8(1):e46945. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.2196/46945>
 20. Ministerio de salud. Informe final de investigación operativa auto prueba VIH Costa Rica. Gobierno Costa Rica [Internet]. 2025 [citado 25 abr 2025]. Disponible en: <https://www.conasida.go.cr/docman/conasida/otros-documentos-de-interes/284-informe-autoprueba-ms-2024/file>
 21. Garollo-Piran C, Cruz-Shibukawa B, Silva-Araújo C, Demitto-Furtado M, Harumi-Higarashi I, Garcia-Lopes M. O conhecimento sobre HIV/Aids: o que pensam os jovens?. *Cadernos GenDiv* [Internet]. 2025 [citado 25 abr 2025];10(4):79-104. Disponible en: <https://periodicos.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/view/52973>
 22. Contreras-García Y, Roa-Garcés J, Alvarado-Figueroa D, Manríquez-Vidal C, Carrasco-Portiño M. Conductas sexuales por sexo en población universitaria chilena que demanda test rápido de VIH. *Rev. chil. obstet. Ginecol* [Internet]. 2022 [citado 27 abr 2025];87(3):194-202. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.24875/rechog.21000036>
 23. Rodrigues FA, De Carvalho-Mendes L, De Lima-Coutinho M, Yaegashi SF, Costa FG, Cavalcanti-Sá JG. Crenças de vulnerabilidade ao HIV/AIDS em adultos jovens em contexto universitário. *Research, Society and Development* [Internet]. 2021 [citado 25 abr 2025];19;10(16):e600101624045. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i16.24045>
 24. Rodríguez-Pérez L, Becerra-Hernández A. Percepciones asociadas a conductas sexuales de riesgo. *Horizonte sanitario* [Internet]. 2022 [citado 25 abr 2025];21(2):292-298. Disponible en: <https://doi.org/10.19136/hs.a21n2.4562>
 25. Rocha KB, Abadi AM, Beltrame B, Pizzinato A. Marcadores sociais, estigma e narrativas de risco e saúde na testagem rápida para HIV entre usuários e profissionais da saúde. *Mudanças: Psicologia da Saúde* [Internet]. 2023 [citado 25 abr 2025];31(2):77-87. Disponible en: <https://doi.org/10.15603/2176-0985/mu.v31n2p77-87>
 26. Cabieses B, Belo K, Carreño AC, Rada I, Rojas K, Araoz C, et al. The impact of stigma and discrimination-based narratives in the health of migrants in Latin America and the Caribbean: a scoping review. *The Lancet Regional Health Americas* [Internet]. 2024 [citado 25 abr 2025];40:1-18. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.lana.2023.100660>
 27. Valenzuela-Oré F, Angulo-Bazán Y, Lazóriga-Sandoval L, Cruz-Vilcarromero N, Cubas-Sagardia C. Factors influencing adherence to anti-retroviral therapy in amazonian indigenous people living with HIV/AIDS. *BMC Public Health* [Internet]. 2023 [citado 25 abr 2025];15;23(1):497-507. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15362-y>
 28. Shafik N, Deeb S, Srithanaviboonchai K, Ayood P, Malasao R, Siviroy P, et al. Awareness and attitudes toward HIV self-testing in Northern Thailand. *International journal of environmental research and public health* [Internet]. 2021 [citado 25 abr 2025];18(3):852-870. Disponible en: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-74274/v1>
 29. Okal J, Lango D, Matheka J, Obare F, Ngunu-Gituathi C, Mugambi M. It is always better for a man to know his HIV status—A qualitative study exploring the context, barriers and facilitators



of HIV testing among men in Nairobi, Kenya. PLoS One [Internet]. 2020 [citado 25 abr 2025];15(4):e0231645. Disponible en: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231645>
30. Bagchi AD, Davis T. Clinician barriers and facilitators to routine HIV testing: a systematic review of the literature. Journal of the International Association of Providers of AIDS Care [Internet]. 2020 [citado 25 abr 2025];19:1-9. Disponible en: <https://doi.org/10.1177/2325958220936014>

Cómo citar este artículo: Maas-Góngora L, Telumbre-Terrero J, Castillo-Arcos L, Nájera-Gutiérrez G, Morales-Rodríguez M. Experiencias de jóvenes universitarios ante realización de prueba rápida de VIH. SANUS [Internet]. 2025 [citado dd mmm aaaa];10(21):e549. Disponible en: DOI/URL.

